

URGENCES PEDIATRIQUES

I. Accidents domestiques chez l'enfant

- A domicile , école , loisirs ...
- Corps étranger trachéo-bronchiques +++++
- Brûlures (thermiques , électriques)
- Morsures (scorpions , serpents , abeilles , chiens)
- Noyade
- Intoxication
- Chutes (traumatismes , plaies ...)

FOREIGN BODY ASPIRATION



REQUIRE TIMELY EVALUATION & TREATMENT
to PREVENT SERIOUS COMPLICATIONS

AIRWAY OBSTRUCTION



FOREIGN BODY INGESTION



GI PERFORATION



II. Corps étranger trachéo-bronchique chez l'enfant :

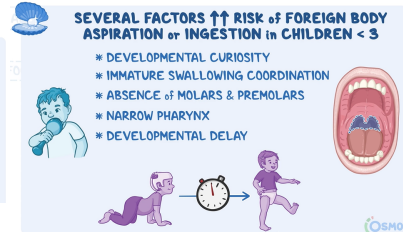
- Inhalation d'un corps étranger (CE) au niveau des VAS = accident domestique fréquent)
- Pronostic vital : encavement pharyngo-laryngé ou sous glottique
- Séquelles respiratoires à long terme
- Diagnostic et extraction précoces
- Syndrome de pénétration++++
- Endoscopie : geste diagnostique et thérapeutique
- Anesthésie-réanimation ++

YOUNG CHILDREN more likely to ASPIRATE or INGEST
SMALL, CYLINDRICAL, & COMPRESSIBLE ITEMS



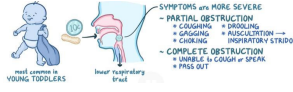
SEVERAL FACTORS ↑↑ RISK of FOREIGN BODY ASPIRATION or INGESTION in CHILDREN < 3

- * DEVELOPMENTAL CURIOSITY
- * IMMATURE SWALLOWING COORDINATION
- * ABSENCE of MOLARS & PREMOLARS
- * NARROW PHARYNX
- * DEVELOPMENTAL DELAY

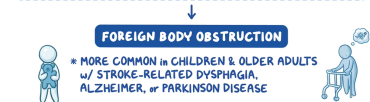


III. Le syndrome de pénétration :

- CE dans VAS accès de suffocation + cyanose et toux quinteuse
- Deux réflexes de défense VAS :
 - Spasme laryngé de fermeture : passage laryngé CE
 - Toux irritative d'expulsion : passage trachéal CE
- SP « complet » ou « incertain »



- * Hx - CHEST PAIN
- * PE - WHEEZING
- * UNILATERAL BREATH SOUNDS
- * RECURRENT PNEUMONIA



IV. Signes cliniques d'une inhalation :

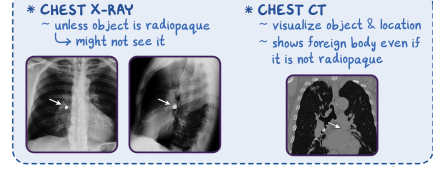
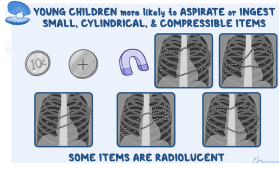
- Accès de toux
- Sibilants unilatéraux
- Diminution unilatérale des MV
- Bronchiolite , asthme ou pneumonie ne répondant pas au traitement habituel
- Symptomatologie récidivante ou chronique

Signes selon la localisation du CE



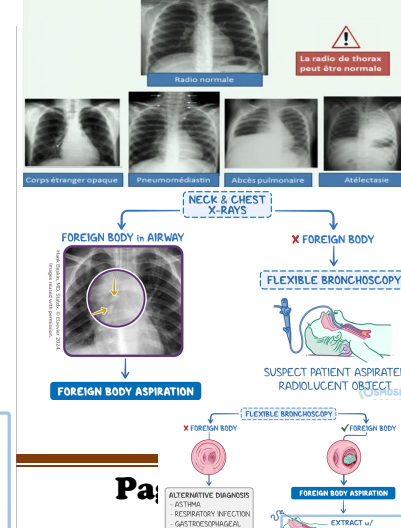
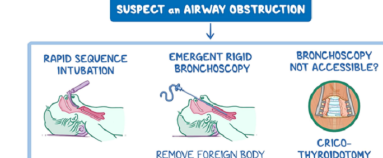
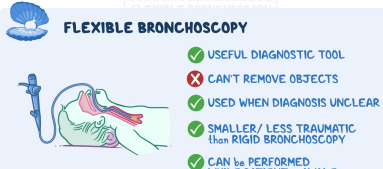
V. Radiographie du poumon :

- CE radio opaque
- Trouble de la ventilation (atélectasie ,emphysème)
- Normale : n'élimine pas le diagnostic +++



VI. Endoscopie respiratoire :

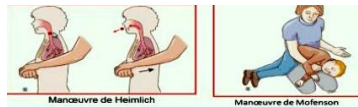
- Seul geste : infirmer ou confirmer et extraire
- Anesthésie générale
- Opérateurs expérimentés :
 - Endoscopiste : Extraction du CE
 - Anesthésiste :
 - Oxygénation + ventilation +++
 - Prévenir le laryngospasme
 - Troubles du rythme cardiaque



QE!!



- PEC de détresse respiratoire



IF PATIENT ASPIRATES OUTSIDE of a HOSPITAL...

INFANT

OLDER CHILD



PATIENT ABLE to SPEAK or COUGH? **DON'T** PERFORM MANEUVERS
MAY CONVERT PARTIAL OBSTRUCTION → COMPLETE ONE

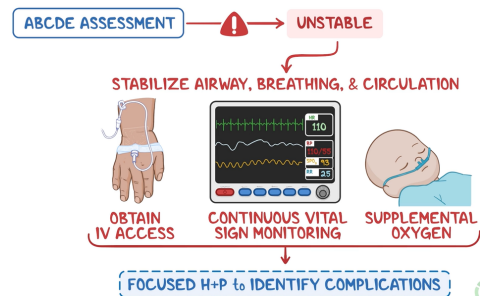
Prise en charge de CE obstructifs asphyxiants :

- Enclavement CE entre cordes vocales ou région sous-glottiques
 ↳ Tableau respiratoire dramatique
- **Lieux de l'accident** : manœuvre de Hemlich (faire une pression sur le diaphragme en se plaçant derrière le patient) , dégager VA , extraction manuelle...
- **Arrivée des secours ou en milieu hospitalier** :
 - Laryngoscopie directe + extraction par **pince de Magill**
 - Intubation + tenter de pousser CE dans l'une des bronches
 - Si échec : court-circuiter la région sous-glottique (abord trachéal)



CE non asphyxiants en dehors d'un centre spécialisé :

- Mise en condition (SpO2 , VV périphérique , O2 , lunettes)
- Adresser dans un centre spécialisé
- Transfert :
 - Position assise ou ½ assise (bras des parents)
 - Eviter toute mobilisation inutile
 - Monitoring



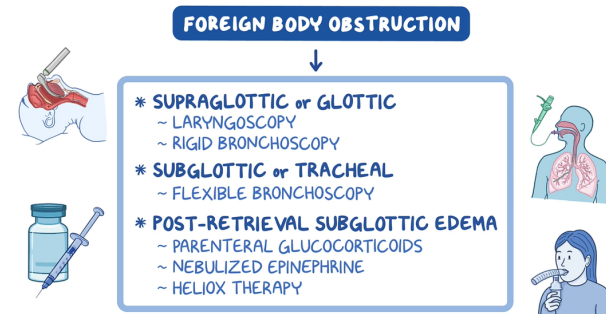
VIII. Evolution :

1. Simple :

- Un réveil rapide en salle et la règle avec surveillance postopératoire et RX du poulmon
- ATB + corticoïdes (pour diminuer l'inflammation)

2. les complications :

- L'hypoxie : inefficacité ventilatoire , hémorragie intrabronchique , barotraumatisme
- L'hypercapnie
- L'instabilité hémodynamique , troubles du rythme
- Le laryngospasme et le bronchospasme
- Les perforations trachéales , œdème laryngé
- Le pneumothorax , le décès
- Bronchectasies (séjour CE long , obstruction complète)



IX. Mots clés :

- ✓ Pronostic vital
- ✓ Diagnostic et extraction précoces
- ✓ Syndrome de pénétration
- ✓ Symptomatologie respiratoire (chronicité , récidive)
- ✓ Fibroscopie
- ✓ Anesthésie , réanimation
- ✓ Gestes de sauvetage